CIRKEL 1

STATION 1-7

CIRKEL 2

STATION 8-14

Station 1

En 66-årig patient kommer till akutmottagningen med 40°C feber och hosta.

Lungröntgen visar lunginflammation

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes**
- **Bedöma svårighetsgrad enligt CRB-65**
- **Ordinera adekvat mikrobiologisk provtagning och antibiotikabehandling**
- **Förklara din bedömning för patient**

Du ska INTE göra kroppsundersökning med status.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 2

Du arbetar på hälsocentralen och träffar en patient som är rökare. Patienten har nyligen fått diagnosen KOL.

Din uppgift är att:

- **Ta en fullständig tobaksanamnes.**
- **Hålla ett kort motiverande/rådgivande samtal om rökning med patienten.**

Du ska <u>inte:</u>

- ta KOL-anamnes eller ge information om KOL.
- informera om läkemedelsbehandling mot KOL.
- undersöka patienten.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 3

Du är primärjour medicin. Klockan är strax över midnatt och din bakjour har precis meddelat att hen lägger sig. Nu går sökaren, ett nummer du inte känner igen.

Inne på rummet finns det en telefon. Ring tillbaka, och hör vad det gäller.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 4

Du träffar en 56 årig man/kvinna på ett planerat återbesök efter DC konvertering av ett förmaksflimmer på en medicinmottagning.

I labstatus noteras bland annat lätt förhöjda levertransaminaser samt ett PEth på 1.1 (= kraftigt förhöjt).

Ett BT taget av sjuksköterska innan besöket är 160/90.

EKG visar sinusrytm fr 82.

Din uppgift blir att informera patienten om dessa fynd och ställa relevanta följdfrågor samt tillsammans med patienten upprätta en behandlingsplan.

Status ingår ej.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 5

En 28-årig kvinna sökte vårdcentralen för två dagar sedan på grund av hjärtklappning och svettningar sedan en månad. Kort status (temp, hjärta, lungor, blodtryck) var utan anmärkning. EKG visade sinustachykardi. Kapillärt Hb, CRP och glukos var normala.

Hon kommer nu tillbaka till dig på vårdcentralen efter provtagning som visar:

P-TSH: <0,005 mIU/L (ref. 0,27 – 4,2)

P-fritt T4: 69 pmol/L (ref. 12 – 22)

Din uppgift är:

1) **Informera snabbt patienten om din arbetsdiagnos utifrån provsvaren**
2) **Komplettera anamnesen kort**
3) **Undersök patientens sköldkörtel**
4) **Ring till endokrinkonsult på sjukhuset och rapportera enligt SBAR**

Du behöver inte:

Informera patienten om dina statusfynd, fortsatt utredning och behandling

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 6

En 65-årig man med känd hypertoni och hjärtsvikt (Ekokardiografi för 8 månader sedan med LVEF 40 %) träffar dig på hälsocentralen pga yrsel och svimning. Besöket bokades för en vecka sedan och patienten har lämnat EKG och blodprover inför dagens besök.

Provsvar och mätvärden finns inne på rummet.

Ta en adekvat anamnes
Bedöm resultat av blodprover och blodtrycksmätning samt patientens medicinering
Föreslå åtgärd
Svara på patientens följdfrågor

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 7

Din nästa patient på hälsocentralen är 84 år och kommer för högt blodtryck och läkemedelsöversyn.

Patienten har även haft en tidigare hjärtinfarkt. Enligt distriktssköterskan besväras patienten av nokturi och yrsel vid uppresning.

Patienten är mycket skeptisk till sina läkemedel, tycker de är rävgift, vill inte ta så många och blandar lätt ihop dem.

Blodtryck 175/88 mmHg, puls 53, BMI 23 kg/m^2

Provsvar (referens):

eGFR 52 ml/min/1,72m^2 (>60)
P-Natrium 131 mmol/L (137-145) mmol/L
P-Kalium 4,1 mmol/L (3,5-4,6)
pro-BNP 133 ng/L

En läkemedelslista finns inne på rummet.

Du ska:

- **Ta en riktad anamnes**
- **Ta ställning till läkemedelsbehandlingen och patientens önskemål om färre läkemedel**
- **Underlätta god följsamhet till läkemedelsbehandlingen**

Status ingår **INTE** i uppgiften.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 8

Du är läkarassistent på en röntgenavdelning och ”går bredvid” röntgenjouren (en äldrekursare som gör ST på röntgen). Du vill gärna visa att du själv kan ställa diagnos på röntgenbilderna!

Nu har ni fått en patient på strokelarm. Du skyndar dig att läsa remissen noggrant och titta på bilderna. Sedan berättar du för din seniora kollega vad du har hittat. Din kollega kommer eventuellt att ställa några ytterligare frågor.

Dina uppgifter är att

- **Läsa och värdera kvaliteten på röntgenremissen.**
- **Själv granska en akut DT hjärna, identifiera och tolka ev. fynd**
- **Besvara frågeställningarna: Blödning? Ischemi?**
- **Visa och förklara ev. fynd och resonera om uppkomstmekanism med kollegan.**

Bilderna visas i UniView (du behöver INTE logga in!)

I rummet finns röntgenremissen med frågeställningar och klinisk information.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 9

En 70-årig tidigare frisk ex-rökare (23 paket-år) har senaste åren haft besvär med slemhosta och ansträngningsutlöst dyspné, hen har svårt att hänga med jämnåriga vid promenad. Hen har dock tidigare ej sökt vård.

Patienten träffade förkylda barnbarn för några veckor sedan. Söker nu på hälsocentralen då hen sedan en vecka hostar gulgrönt slem och har blivit mer andfådd. Förnekar bröstsmärtor.

Status: Opåverkad i vila, inga ödem. Temp 37.3, Saturation 93%.

Hjärta och BT: Normala fynd.

Lungor: spridda sekretbiljud, förlängt exspirium vid forcerad exspiration, men inga tydliga rhonki.

Lab: SR 16 (ref:0-13 mm), CRP 28 (ref:0-5 mg/L), LPK 11.0 (ref:3.5-8.8 10^9/L). EKG, NT-proBNP och troponin normala.

Du ska:

Informera och förklara <u>för patienten</u>;

- **Preliminär bedömning/diagnos, inklusive motivering**
- **Indicerad behandling samt information/råd i akutskedet**
- **Vilken uppföljning / utredning som bör erbjudas - och när detta ska göras**

DU BEHÖVER INTE TA NÅGON YTTERLIGARE ANAMNES ELLER UNDERSÖKA PATIENTEN

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 10

Du träffar en patient som söker för feber och nattsvettningar.

Din uppgift är att undersöka (status) patientens lymfkörtelvävnad (ovan naveln).

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 11

Din nästa patient på hälsocentralen är 75 år gammal. Personen kommer till dig på misstanke om läkemedelsbiverkan av en blodtrycksmedicin insatt för en månad sedan.

Undersökningsfynd före besöket:

- Blodtryck: 120/70 mmHg
- EKG: sinusrytm, puls 70/minut
- Normala Na, K, Kreatinin, HbA1C, Kolesterol-status
- Urinsticka normal

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes, både bakgrund och aktuellt problem**
- **Bedöma och informera patienten om det kan vara en läkemedelsbiverkan**
- **Bedöma om medicinändring är nödvändig, ändra i så fall i samråd med patienten**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 12

På denna station möter du Ingrid 66 år som nyligen diagnosticerats med diabetes. Hon medicinerar med Metformin samt Candesartan. HbA1c 50.

Uppgiften är att genomföra fotundersökning vid diabetes samt informera patienten om din bedömning av fotstatus och besvara hennes frågor.

Övrig klinisk undersökning och behandlingsförslag ingår ej i uppgiften.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 13

Du är underläkare på en vårdcentral.

En 30-årig industriarbetare har skickats till vårdcentralen från företagshälsovården på grund av ett avvikande EKG. Det har inte förekommit några besvär från hjärtat.

Blodtryck 125/75.

Din uppgift är att ta hjärtanamnes, göra ett hjärtstatus och tolka EKG. Vid hjärtstatus ska du ange vilken hjärtklaff du hör var.
Du ska också föreslå eventuell fortsatt utredning och svara på frågor från patienten.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 14

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.